

医津一筏

江之兰

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
医津一筏	5
《医津一筏》跋	26

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

医津一筏

（一名《内经释要》）

歙县 江之兰 含征 著

和县 高思潜 考 正

吴县 张炳翔 叔鹏校录

治病必求其本

脾喜燥，伤于寒湿则不能消磨水谷，宜术附以温燥之。然脾阴不足而谷亦不化，又不可以温燥为治。

有思虑伤脾，脾虚不能统血而矢出者；有思虑伤脾，脾虚不能消谷而作泻者。此皆以回护中气为本，勿治其标。

有肺虚不统卫血，血溢妄行，随气出于鼻为衄。如动气在右，汗之令衄是也。脾虚不能行津于三阴，胃虚不能行气于三阳，气日以衰，脉道不利，其血悉皆中积，此而欲消，其留瘀当以参耆监之。

胎已数月，忽下血不止，有癥瘕害者，当下其癥而胎始安。设不知此，但一味养血安胎，是为癥瘕树帜也，胎可安乎？

刘澹庵曰：下癥安胎，必用驱逐峻剂，虽有故无殒。然不定其虚实而施之，恐非定法也。

火气逆上是肝肾之阴失其龙雷蛰伏之性而上逆者，至于胃中湿热下流，又是邪气乘其木而阴气反走于上，俾上焦之阳不伸而肺中治节之令不行，故见为鼻塞、胸满、涎溢、恶寒战栗之证。又咳嗽烦冤，是肾气之逆也，其所以上逆之故，亦有此二者虚实之异。推此则治痰莫先于降火，降火之法，亦须识此二者虚实之异。又平脉云：少阴脉不至，肾气微，少精血，奔气迫促，上入胸膈。夫少阴脉不至，是先天元阴元阳受伤。肾者，先天也；脾胃者，后天也。先天既已受伤，则不能生乎后天，故脾胃之阴阳亦伤，不能运化水谷而生湿热，热下流则膀胱之气化不行，浊气因而上入，浊气上入，肺气便壅，脾气愈滞，于是为痰为饮而腹胀食滞之症形焉。其少阳生发之气郁而不得升，为周身刺痛，为呕逆吐酸。心主之阳，为浊阴所乘，则为心悸怔忡。是肾之一脏病，而五脏六腑皆为之不宁，故养身莫妙于节欲也。若不知此，而但以行痰利气为治则燥，痰伤其阴，利气伤其阳，不坐困乎？此又专主肾虚而

言也。

心肾不足，小便浑浊，中气不足，溲便为之变；金衰则水涸，溺色变为黄赤。此皆正气虚而生邪热，当推原其本而补之，苟徒执水液浑浊皆属于火一语而施治，病安能愈？

饮食劳倦，损伤脾胃，始受热中，末传寒中，要知始受之热，因谷气不得升举，壅而为热又火，与元气不两立之热，非实热也。故在始受之时，已云劳者温之，损者温之矣。病久安得不为寒中耶？东垣谓冲任之火传之督脉，督脉挟太阳寒气逆克丙火，似失之凿。

子母情牵，仇仇肆虐，或胜克乘薄之不一，又本脏本脉其别者，或走他脏他脉，一脏病往往挟他脏而见证者。

邪之所凑，其气必虚。邪乘虚而入，是虚为本邪为标，故去邪不可不加以养正，此一注脚，人所同也。然亦有身体壮盛之人，暴受邪气，如外感风寒，内伤饮食之类，本气未必皆虚，受病之后，反显虚象，若营卫受邪，则屈伸不利，动作衰之；脾胃受邪，则四肢无力，恶食呕泄之类。此邪气既凑之后，其气亦必虚，是虚因邪而显，邪为本虚为标，斯时但当亟去其邪，而正自复，不必顾虑其虚，用药牵制，此一注脚，余所独也。

治病当知标本矣。然犹不可不知标中之标，本中之本，如脾胃虚而生湿热，是虚为本，湿热为标也。至湿热下流膀胱之气化不利，是湿热为标气化不利为标中之标。至气化不利逆而上行，噎塞喘逆，又标中标之标也。推此而逆求之，则本中之本亦可得矣。

阳旺生阴，气不足亦令人口干而津液不通。

喘而短气，须别寒热虚实，分类治之。至于哮则素有之痰之火，风寒所束而发，但看其人之强弱，用药轻重可耳。

肺本金寒水冷之脏，然既已汗吐下损津液而成肺痿矣，岂清凉之品所能复其津液乎？此仲景之竟用桂枝人参姜枣所宜详究也。

火与痰本气与津液也，无病则为气与津液，有病则为火为痰。然致病之由，不过内伤外感，有余不足而已。求其本而治之，则痰消火灭，故曰见痰莫治痰，见热莫治热者以此。

内伤外感悉能致劳，苟不察其虚实，但施养阴清热之套剂，则虚者未必受补，而实

者愈实矣。

失血证毕竟属热者，多世有用寒凉而反剧者，盖有气虚之火，有血虚之火耳。冲气上逆有上焦之阳不足而阴气上于者，有下焦之阴不足而阴火上逆者，有脾胃之湿热下流而肝肾之气不能固守于下者，俱挟冲脉故耳。

邪火内炽，阳事反痿，苦寒泻之，阳事勃然，火与真阳势不两立，如此世人以助火之剂，冀回真阳，非徒无益，而又害之。

所谓虚风者，似风非风也。然亦有阴阳之别，阴虚是热则生风，阳虚是阳气不能卫外。

卫为阳，阳虚不能卫外，故中风。风为阳邪，以类相召故也。但风为阳邪，既中之后，每多显阳热之症，此不可不推求其受病之本，而务从事于见病之标也。诸病皆治其本，唯中满与大小便不利当治其标，以证之危急，不暇为本计也。余谓果系实证，则不难消导之，通利之治其标可也。若涉虚证，其法可行乎？仍当治其本。

东方常实，有泻无补，其说有二。一者肝为将军之官，其性刚劲急速；一者木火同居，风乘火势，火助风威，皆母赞其胜也。若言其本，则乙癸同源，养血与滋阴并急。

颠、狂、痫皆主于痰。颠是虚而致痰；狂是实而致痰；痫是风而致痰。虚实风为本，痰为标也。

痰在肺曰燥痰，又曰气痰，以肺为燥金而主气也。燥为本，气为标，其痰涩而难出见为证也。往往胸膈阻塞，关节不利，不知者以辛香燥热利其气，燥者益燥，气愈不利。

肺虚咳者何也？失其降下之令也。徒降其气，咳愈频矣。

黄昏咳多者，是火气浮于肺，此阴虚之火，故宜五味子敛而降之。

诸痿喘呕皆属于上，上者，肺也，不得以香燥利气。

湿胜则濡泄，当以燥剂治之，然逆秋气则伤肺，冬为飧泄，此肺移热于大肠之病。若以温燥治之，是益其病也。

渴固多热，然内外伤感悉能令津液不行，而渴须求其自。

三阴结是水之本，至肺气不利，发为浮肿、喘嗽、口干、小便涩、腹满、黄汗、身重不能转侧、阴肿。阴湿则又水之标也。

寒邪在标，郁热于经而令咳血、衄血，解表自愈，麻黄汤杏子汤是也。心肺有疾而鼻为之不利，不必主专于风寒也。

治病必求其本。本者，下为本，内为本。故上热下寒，但温其寒而热自降，表寒里热但清其热而寒自己，然须加以反佐之药，以免格拒，至于先伤于风而后伤于寒，先伤于暑而后伤于湿之类，又当相其轻重缓急而施治。

有者求之无者求之，盛者责之虚者责之

四肢无力，动作衰乏，虚也。然邪客营卫则出入之道废，中焦有阻则升降之机穷，亦能见证如此，故曰无者求之。

诸痛无补，言气逆滞也。虽然壮者气行则愈，怯者着而成病，真气虚乏之人，诸邪易于留着，着则逆，逆则痛。疏刷之中不可无补养之品，徒恃攻击，则正愈虚，不能送邪外出，邪愈着而痛无休止也。遇斯疾者，攻补兼施而不愈，遂宜屏弃一切，其要又在断厚味，远房帟，使邪无所助，而正气日胜，然后佐以疏刷，击其惰归，病无不愈。但邪气方炽，病者正在呻吟痛苦之时，医者教之以如此，如此是犹子舆氏教滕君以强为善，鲜不以为迂阔而远于事情者也。又若脾胃亡液，焦燥如割，宜用真生芩脉汤。阳涩阴弦而腹中急痛，当用小建中汤。肝气不足，两胁下满筋急，不能太息，四肢厥冷，发呛，心腹痛，目不明了，爪甲枯口而青，宜补肝汤。房劳过度，肾虚羸怯之人，胸膈间多隐隐痛，此肾虚不能约气，气虚不能生血之故，气血俱虚则凝滞而作痛，宜用破故纸之类，温肾芎归之类养血。又胸痹痛，有真阴虚而然者，有元阳虚地气上干而然者，头痛有气虚者，有血虚者，有肾虚者，皆不可不无补也(芩，地黄也)。

妇人因产，去血过多，腹中急痛，是肝木无血以养，宜当归建中汤，亦是痛而应补者。

妇人居经，血弱气盛，孤阳独呼阴，不能吸阴，为积寒。阳为聚热，故时发洒淅、咽燥、汗出，或溲稠数多，唾涎沫，其脉右浮大左弱涩，此当养其血，所见之证勿计也。

证象白虎，误服白虎汤必死，言治假以真也。

寒邪闭其营卫，当以升发之药散之。然素有痰热之人，遇此升发之药，痰随气上，闭住肺气，皮毛为之壅遏，邪愈不得泄，病反增据，又当以苦泄之。

心火不得越则郁于小肠，肺气不得泄则郁于大肠，小肠下口，即大肠上口故奔迫无度，里急后重而成滞下，此是风寒内缩使然。徒责之湿热，未能万举万当，所以治痢亦当与治疟，半表半里同法。

食积痰留舍肠胃之间，气行则出，有似鱼脑，间以血丝，闭气滑肠，状如痢，利反快，不可作痢疾治也。

热则生风，痿痺不随，而有风象，医以风治之恐不免致痿也。

便泄肛门热有火热有阳陷二端。

先天者，无形之虚神而已矣。后天者，有形之实则气血也。治先天当以神治神，治后天当以形益形也。但神虚则气血不生，神乱则气血不宁，气血虚则神无以养，气血乱则神为之迁，此又当消息之耳。

张汉颐曰：气血即神之窟宅，不治气血何由治神？以神治神立论，如此尚须着落耳。吾常谓谈医之道不可一语模糊，令人徒作天际真人想也。

天地阴阳，停匀方不崩不拆，人亦如之。稟畀之后，嗜欲不节，起居无时，七情六淫所伤致，此阴阳有所偏损则偏胜，故见以为有余而实也。有余但治其偏损者，而有余自平。

形气有余，病气有余，泻之可也。形气不足，气病。气不足，补之可也。至若形气有余，病气不足，形气不足，病气有余，当责有无真假。东垣云：但补泻病气之有余不足，不必顾其形气之有余不足，似非确论。

幼科大便黄赤，属热是矣，其青白亦未可专以为寒。夫水谷入胃，入大小肠，肠胃无邪，则水谷以传次化者，清入营卫化精微，浊者下广肠成糟粕，粪为之变。设肠胃有寒，水谷不得热腐，故下利清白，完谷不化。然肠胃有热，水谷不得停留，亦下利清白，完谷不化，不得专以为寒也。

肾为先天之本，脾为后天之本固矣。然肺金不足，或不得其平，亦不能生水。心火不足，或不得其平，亦不能生土，徒责之脾肾无益，故病亦有治标而得者百病不离乎火。火者，天地所有之气，亦吾身所有之气也。从外入者，天地亢害之气，吾身中以类相感召，亦令此气为之亢害也。此伤暑受热是矣。至若七情，以及风寒燥湿动乱为火者，以火喜条达而恶遏抑，今以七情及风寒燥湿抑遏之，动乱为害，然发之、泻之、制之、克之可也。迨夫相火则其体藏于右肾之中，所以配左尺之水，俾此水得以彻于上下，周于四表，充肤泽毛，若雾露之溉，虽水为之实火为之也。设使阴虚，此火失其窟宅，游行于四肢百骸，五脏六腑之间，而为大患。阳虚则此火

无根而脱出，为患亦然。此不可以湿折水灭，唯当相其人之阴虚阳虚而补养之。独是体虚之人，易于受邪，或内外伤感，抑遏成火，则补虚之中，不可无泻实之药，若六味地黄丸加黄柏知母等方是也。审此则用药不难中肯綮矣。

张永孚曰：相火禀命于命门。真水，先天水火原属同宫，水以火为主，以水为原。下论曰：设使阴虚此，火失其窟宅，阴虚即水亏火脱，出即阳虚，岂六味加知柏反可平之者耶？

诸疮将结痂时，必极痒，盖痒为虚。先时邪盛则痛，今邪去则虚，虚则痒，邪去则痂。若痂疽初发便痒，是邪盛正虚也。

上有绝阳之络，下有破阴之纽，皆是气虚不能缉续故也，补之所以辑续之耳。但正气一虚，邪火便盛，又谷气不得升举，壅而为热。又气虚不续，而有留气，为喘、为满、为痛，往往见有余之证，令人异首畏尾，而不敢径行施补，迁延就毙者有之。

肺出气，肾纳气，所谓一呼天根，一吸地穴，循环无端，应刻而不疾徐者也。此气一虚，则断而不续，或短气不足以息，或壅而为满，虽云气不归原，其实只是气虚也。若阴虚阳无所附，上见喘满，此则真是气不归元耳。

言而微，终日乃复言者，此夺气也。湿家短气，声如从瓮中出，此气为湿所持而然，然则有形之伤，悉能令气短，不能定以为夺气也。

诸痛皆主于气滞，但气滞之由，有虚有实，不得专主疏刷。

脚肿无非湿热，盖浊邪下先受之也。膏粱厚味之人，由湿热下流，田野耕凿之人，由寒湿外侵，是为实邪。中气素馁，土虚不能制湿之人，是为虚邪。二者虽有虚实之不同，然皆本于湿，唯是一种。形瘦多热，年老阴虚者，每至日午脚面浮肿，此何以故？予尝思之，阴虚而至暮年，阴愈虚矣。虚极之阴，便不能吸气归原，而升举其阴，于是阳独浮于上，阴独沉于下，而脚至暮浮肿也。

汗多亡阳，下多亡阴，言阳主外阴主内也。然岂无辛热而损盖覆之阴，岂无苦寒而伤闭蛰之阳？必以见证何等而参之以脉，方为不误。

刘澹庵曰：汗多亡卫外之阳，下多亡主内之阴，二者应之速。汗，不过一汗再汗；下，不过一下再下，而遂亡阳亡阴。辛热损阴，苦寒伤阳，则有渐积使然。

治风热燥火寒湿之中，尤必以真阴为先务。治寒湿温燥之中，尤必以真阳为先务。然风热燥火，亦有亡阳者，阴虚阳无所附也。寒湿亦有亡阴者，阳虚阴必走也。

厚味之人，不妨消导，然情欲过度，又宜慎之。藜藿之人，最忌消导，然淡食形盛，又在不禁。

凡病烦躁而愈者，以邪气盛时，正不能与之争，反相安于无事，及其正复而与邪争故烦躁也。以此知瘫痪不随之证，无痛痒反难瘳，以正为邪并学而能复耳。

病有在下者，其见证反在上，蓄血发狂是矣。在上者，其见证反在下，肺气壅，大便频，肺气虚，小便数是矣。在表者，其见症反在里，如三阳合病下利是矣。里者其见症反在表，如热深厥亦深及面反戴阳是矣。

风温、温症，得之冬，中于风寒，遇温而发，其气自内而达于外，故多汗。不比风寒外束，闭其营卫，当须发汗解肌也。故以发汗为逆，然其邪自内出。若因汗而骤加敛表之药，邪不得越，为害匪轻，务必相其人之虚实，清解得宜。

虚不受补，邪实也。实不受攻，正虚也。

气有余便是火，气焉能有余？惟是少一分之阴，便多一分之气，此一分之气，无所归宿，而为火矣。

张汉颐曰：血阴气阳，二者属人，未见其有余。少一分阴，便多一分火，火有余则似气有余也。如此说方透。

阴阳有偏胜为病者，有偏负为病者，然偏胜之中，往往有偏负之假象，补之则益胜。偏负之中，往往有偏胜之假象，泻之则益负。

清气不升，浊气不降，七情六淫，气血饮食痰皆能为之，苟不求其本而但利其气，气之升降得乎。

疟疾无汗，要有汗固矣。至于有汗要无汗，此亦不可不斟酌也。虽疟邪有虚实之不同，其始未有不因暑邪，内藏阴邪，外束所致，邪气乘阳则阳盛，阳盛则外热，热则腠理开。又暑为阳邪，阳邪多汗，故疟症往往多汗，数发之后，邪气渐衰者，亦以邪从汗解，所以疟疾虽众，不救者少，亦以此故也。岂可因其多汗，而遂加以固表之药，邪无从解矣。故古人但言扶正为主，亦未尝言固表也。余谓汗少不妨更汗，若汗多不必更发汗，似为得之。

医家要明不可治之病。而后知有可治之病，不可治之病，真阴元阳虚极故耳。如形盛脉细，少气不足以息者，死。形瘦脉大，胸中多气者，死。世人徒读其文，而不绎其义，岂知形盛脉细，元阳虚也，少气不足以息，虚之极也，故死。形瘦脉大，真阴虚也，胸中多气，虚之极也，亦死。又如温病，穰穰大热，脉反静者，死。下

利脉反大者，死。又皆正气虚，而邪气实也。正不胜邪，故死。可见，凡病之不可治者，由真阴元阳之虚，则其可治者可意会也。

邪气之所凑，其气必虚，故曰：不能治其虚焉。问其余，然亦不可执也。岂无壮年之人，违年之和，遇月之虚，及思虑应酬之间为虚邪贼风所乘，又因脾气健旺，过啖甘肥炙焯酿成胶痰实火，则发表攻里。如河间之推陈致新，有何不可？因循顾忌，则反累伤正气，所谓五虚死，五实亦死。又云：毋实实，毋虚虚。今又不论虚实，动手使用补益，自谓调元之手，亦胶柱而鼓者耳。

庸工但执热则流通，寒则凝滞二语。一遇诸腹胀大，痰气阻滞，与夫大小便秘，遂行温利之药，不知寒热虚实是病皆有。如诸腹胀大皆属于热，在心曰热痰。气有余便是火，热则燥涩为瘕。此等可温利乎？夫水下二刻，一周循环，此阴阳相抱之气而然，偏阴偏阳能之乎？故曰气化则出，其旨深矣。

手足心热及夜热，有虚有实，不得执定阴虚。

鬼贼相刑，固为恶候，然于理为顺，微邪薄所不胜，由己之虚也。于理为逆，所以病亦有微邪而笃者，贼邪而愈者。

营卫之或疾或徐，脾胃之或寒或热，痰因之而中积，血因之而留止，不亟为开囊活血，陈者不去，新者不生，始因虚而致实，终因实而致虚，此攻击之品，不能无也。

肝欲散，急食辛以散之，肝之实也。肝苦急，急食甘以缓之，肝之虚也。推之他脏，亦然。

女人血结胞门，则上焦之阳不得入于阴，在下则小腹里急，五液时下，在上则孤阳独浮而为发热，为掌上烦，为唇口干燥，又宜先开痹破阴结引阳下行，不徒专恃滋阴。

小便少亦有肺热，不能通调水道者。

风湿症以去苍术加白术冲和汤为当。风寒症亦有风，有时开其腠理而自汗者。四时伤风，亦有自汗者，耆芍宜慎。

风火皆阳，能开其腠理，皆自汗多汗，一则桂枝，一则白虎，不可紊也。廉泉开有中焦郁热者，有中风舌纵者。

虚则不能运化精微，郁而为热，此阴黄之由。

紧敛劲缩，燥之体也，风胜反似之，兼胜己之化也。

营卫受气于中，中有所阻，则营虚发热，卫虚恶寒，故气血饮食痰皆能寒热者质此。

青筋症，面青唇黑，手足厥冷，气逆血冲使然。医者，意中不先有此一症，鲜不认作阴经伤寒也。

膈间有热痰，热气上蒸，脉道壅塞，故令人头风目昏。治以酒蒸大黄，自上抑之，所谓鸟集高巅，射而落之也。此症甚多，眼科未尝载，予每治验。

人身中有形之物皆属阴，故曰瘦人血虚。然肥人亦有痰生热，热生风，风生燥，燥则伤阴，往往亦有阴虚者，不可不知。

痰之汹涌上焦，结聚胸中，皆由于气。故治痰莫先于治气，治气又莫先于降火，破气清火则痰自消，此则言乎六淫七情，怫郁暴积之痰耳。若日积月累，老痰凝结，又当积渐以消释之，更当相其人之阳虚阴虚，助以调补。苟如前法，将见痰未降而气已消，为患不可胜言矣。医者晓得当汗而汗，当下而下不难。晓得当汗而不能汗，当下而不可下为难。仲景之可与不可，宜详玩。富贵之人，恣情纵欲，自揣不足，求补于味，不知肾虚则胃弱，不能消磨其厚味，不生津液而反为痰涎，中州不运矣，气愈弱矣。病者不察虚中有实，医者又不识实中有虚，攻之不安，补之无益，聊藉参耆，苟延岁月，一旦奄逝，自谓其命，宁不悲哉！

按之痛者为实，不痛为虚。夫按则气散，即实亦有因之而痛减者；虚则气壅而为痛，复按之气愈壅，即虚亦有因之而益痛者。正未可执此而定其虚实也。若以热手久按痛止为寒，不止为热，此则差可必耳。

七情所伤，动乱其火而伤阴，此易知也。七情所伤，动乱其神而损气，此难知也。要知神乃气之帅，神乱则气自损耳。

疏其气血，令其调达，而致和平

膏粱厚味之人，形盛气衰，以气不足以充故也。然气不足则生痰，以为气不足而补之，则痰气愈滞，胸膈不利，营卫不通，加之以肾元衰耗，厥气上逆，诸病丛生，故善治者补益之中不可不兼之伐痰。然端本澄源，又在远房帟，断厚味为先务也。

五脏各有专司，六府互为输泻，不啻百僚帅师矣。十二经以行于表里上下，十五络以络之奇经八脉，以藩蔽之，不啻金城汤池矣。然主不明则十二官危，土崩瓦解之势一朝而至。可见，善养生者，全在收摄此心。程子曰：心要在腔子里。朱子曰：

必使道心，尝为一身之主，而人心每听命焉，则天地万物位且育，岂但区区却病而已。

刘澹庵曰：人身别有一主，非心也。谓之君主之官，当与十二官平等，不得独尊心之官为主。若以心之官为主，则下文主不明则十二官危，当云十一官矣。此赵无间所见甚超也。阴虚则阳无所附，气有升无降，法当以滋阴之药为君，敛降之药为佐，苟徒降其气则浊未必降，而清且随之矣。阳虚则此气中断，气有降无升，法当以补中药为君，升举之药为佐，苟徒升其气，则清未必升，而浊且随干矣。此治阴阳偏虚不易之理外，此或七情逆滞，或气血饮食痰阻碍中焦，妨其升降出入之路，其人元气未亏，不妨升之降之可也。

然以上悉指后天有形气血而言。若论先天元阴元阳，则阴虚阳必薄，阳虚阴必乘，此时但当峻补其阴阳，无暇为升降治标计也。

八珍汤固是阴阳平补之剂，然人禀受不同，岂无偏胜偏虚？则知少补一分之阳，不足以配阴；少补一分之阴，不足以配阳。多补一分之阳，则阴气耗竭一分；多补一分之阴，则阳气牵滞一分。此调理不足之症，最为棘手，况乎体虚之人，外淫易犯，内情易起，饮食易停，痰血易滞，尤不可仅责其所无而不求其所有也。

阴虽主降，然必欲从天而降，阳虽主升，然必欲从地而升，方谓之阴阳相抱。故用苦寒以治火之王，辛温以治水之王，病未去而寒热反增。

邪正相搏则痛。若正不胜邪，不妨补之，然须佐以去邪之药。若正气太虚，又不妨纯补，俟其正复，然后加以去邪之药。兵法云：先为不可胜，以待敌之可胜。又曰：善战者，立于不败之地而不失，敌之所以败也。

虚痛虽有气血寒热之分，然皆主于气郁滞，气不滞则痛无由生。气虚则气行迟，迟则郁滞而痛；血虚则气行疾，则前气未行，而后气又至，亦令郁滞而痛。故气虚补气，血虚补血，俾阴中有阳，阳中有阴，反其漏下二刻一周，循环之常，痛自愈也。

适事为故

世间病之杀人者十三，而药之杀人者十七，皆由不知阴阳虚实之理也。如劳瘵未必遽死也。欲退其蒸，频用寒凉，则脾泄而不可救矣。膈噎未必遽死也，欲开其郁，频用香燥，则三阳结而津液竭矣。水肿未必遽死也，欲利其水，频用淡渗，则阴亡而成阳水矣。如此之类，未易枚举。操司命之权者，岂可不知中病即止之理！

反佐以取之

阳虚而见阳热之症，此是真火无根而脱出也。阴虚而见阳热之症，此阴虚阳无所附而然也。阳盛而见阴寒之症，阳盛拒阴也。阴盛而见阳热之证，阴盛格阳也。四者用药差讹，死生反掌。

阳虚阴必走，水无气以鼓之，不能周流循环，是以走也。故有阳虚失血者，然血本水类，水就下，既无气运之上行，则当从二阴之窍脱出。今阳虚之血，往往见为吐衄者何也？要知命门火衰之人，真阳脱出，浮游于上，阴血扰乱不宁，亦从而脱出也。海藏云：激而为吐血、衄血者有之，心肺受邪也。下而为便血、溺血者有之，肾肝受邪也。其言可想。

阴阳格拒，药用反佐，谓之反治可也。至于真寒而见假热，真热而见假寒，药用反佐，其实正治也。

血脱益气，是阴虚阳无所附，故不得不先补其阳，然后徐调其阴，此从权之治。寻常阴虚劳瘵，不得以之藉口，而以参耆为家常茶饭。

热则生风，虽有虚实之不同，然皆为假象也。只是古方养血清热之中，而以风药为佐，此不可不深惟其义。夫风者，肝木之气，少阳之火系焉，喜条达而恶抑遏，火动风生，失其条达而抑遏也，佐以风药，以辛利之，而复其性耳。

黄连、苦参，久服而反热；附子、干姜，多饮而反寒，虽云久而增气，反招见化之尤。究不外寒之不寒是无水也；热之不热是无火也。

痉证在外，阳病者仰而不能俯；在内，阴病者俯而不能仰，此不易之论也。而海脏附子散方下云：治伤寒阴痉，手足厥冷，筋脉拘急，汗出不止，头项强直，头摇口噤。夫头项强直则非俯而不能仰也。奈何？阴病亦然。意者，阴盛格阳于外，阳经热盛，故如此。如厥阴经，热深厥亦深，亦舌卷囊缩，此又是热乘其本，而阴反走于外也。予曾见头项强直之证，有与寒凉而随毙者，盖未达此理故耳。

肾者，胃之关，从阳则开，从阴则阖。阳太胜则开而为消，阴太胜则阖而为水明矣。仲景治水肿，主之以肾气丸，而治消渴亦然。甯不与阳盛有乖乎？予谓：此之消是肾中阳虚不能收摄也。此之渴是肾虚引水自救也。俞嘉言谓：肾水下趋，故消；肾气不上腾，故渴。均用此丸，蒸动肾气，恐未必然。

上虚，固是阳虚，以身半已上同天之阳也。下虚多是阴虚，以身半以下同地之阴也。然一阳根于地下，而水出自高原，阳虚则有降无升，或虚之极而真阳脱出，阴虚则有升无降，或虚之极而真阴四射，又不可不进求焉。

阳中不可无阴者何？无阴则不能降也。阴中不可无阳者何？无阳则不能升也。故曰：

天以阳生阴长，地以阳杀阴藏。

渴而汗出，小便利，大便硬，似不宜更利小便，重伤津液也。然仲景又有宜五苓散者，此盖通因通用，其小便利乃是热邪偏渗于小肠，故行乘势利导之法，如下利之用承气也。

燥与湿不两立之势，然湿则郁，郁则热，热则燥生，有不得不然之理，亦湿位之下，风气承之，风生燥也。仲景诸黄猪膏发煎，茵陈五苓散，分治气血分之燥旨哉！

截疟劫嗽，本非王道，亦有不能不用。如疟邪已去八九，胸中有痰癖留恋，其邪斯时不暇，顾其余而直攻其痰，则邪无留恋之处而病自愈。设邪气方张，则驱邪之未遑，正气已脱，则补救之未遑，敢用截药乎？咳嗽邪已去八九，而肺气虚耗，虚则气逆，斯时亦不暇顾虑，其邪之未散，而直收涩之收，以止逆涩以固脱，则正气复而余邪自解。设邪未去八九，而虚邪逆上，敢用劫药乎？

从少从多观其事也

伤寒黄连汤，因其人本虚寒，阳邪传里，兴胸中之阳，两阳相合故为上热。下焦之寒则自若也，所以上热下寒，斯时已成，乖否之象，病可愈乎？是汤之不可缓矣。

六气相合，有差多差少，有真象有假象。真假之中，又复有差多差少，所以不可不知，从治之法也。

阳虚易于受寒，阴虚易于受热，以身中之不足，感召外邪之有余，此流湿就燥之义，且无以御之之故也。然亦有阴虚中寒，阳虚受热者，其邪盖因虚而招致，不必同类而感召也。治热则恐亡阳，治寒则虑亡阴，最难为矣。

阴虚只当发热，不当恶寒，然亦有恶寒者，热胜反兼胜己之化也。气虚只当恶寒，不当发热，然亦有发热者，火与元气不两立也。

小便黄赤，多主于热。经又云：肺气虚则肩背痛寒，少气不足以息，溺色变。又冬脉不及令人月少清脊痛，溺色变。二者言肺肾虚寒而小便变，何虚实寒热相悬，而其病则同。若此要知肺虚则不能通调水道，肾虚则关门不利，皆能郁而为热，热则溺色变，是热则一第有虚实之不同耳。亦不可不知从治之法也。

张汉馥曰：小便赤变有中寒，而如是虚人老人恒多。溺色变，热则一，未应说也。

必伏其所主而先其所因

丹毒之与发斑，亦有表里致病之殊。丹毒则系感触时行不正之气，滞于营卫，斑则由阳明瘀热而发于肌肉耳。二者虽宜清热，在丹毒不可不加以解散，在斑又不可不顾其虚，盖斑亦有亡阳于外者，如丹溪所治完颜小将军是也。又丹疹随出随没，系阴虚而虚火游行。又身痒瘾疹，有因风湿及痰者。

风伤卫，卫伤则不能固卫津液，故令自汗。此说深得用桂枝汤之旨，表实则里虚，此一语人往往潦草看过，而不求其所以然，盖营卫受气于胸中，而脏腑亦受输于营卫，今营卫受邪而实，则失其转输之职，而里为之虚，亦医道之浅而易忽者。

张永孚曰：营卫受邪而实，当言卫受邪而实，则营失其卫而里为之虚，不然表实里虚一语，终欠明耳。

病有大相悬殊，而其理则同者。如肺痿之与痿蹙肺痛之与痹病不同。然一本于阴虚，一本于阳实，其理则同，故学者不可不知比类。

人身中三阳经卫于外，三阴经守于中，原无胜负，第阳气喜舒而恶郁，郁则热生，七情六淫皆能令郁也。又天气作阳，厚味助火，又劳倦则阳和之气动乱为火，如是则火与热搏击于身形之中，未免伤阴，阴伤则阳旺，阳旺阴愈伤，以至偏胜偏虚，故丹溪发阳有余阴不足之论，世人读其言不精求其义，毋怪其有吠声。

太阴厥阴无热而少阴反有热者，缘少阴与太阳为表里，其经亦里之表，又少阴藏真阳，斯二者俱是反有热之故也。观其用麻黄附子细辛汤概可见矣。

胃偏于阳则消谷易饥。又曰：邪热不杀谷。盖消谷是胃阳发露，不杀谷是邪热耳。

《伤寒论》、《金匱要略》岂每证治验，然后笔之于书哉！不过以正气与邪气相搏击在何经，又系何邪见证应作何等立其例，论其理耳。然却非杜撰，后人亦将此等理明白于胸中何难？因此及彼昔贤议论真筌蹄也。又《要略》者，是举其要而言扩而充之，存乎其人。

燥极而口噤，善惊数欠者，以木被金囚而不舒也。妇人藏燥喜悲伤，亦是此意。

寒之而热者取之阴，热之而寒者取之阳，各求其属

当天地不交之时，阳独治于上，无阴以盖覆之。阴独治于下，而填九窍之原明者，当于阳药中加以收敛降下之品，使阳归于阴，阴药中加以升腾生发之味，使阴加于阳。

过用阴精而阴脱于下，暴喜伤阳而阳脱于上，则各补其阴阳。其有亡阴而阳脱于上

，亡阳而阴脱于下，则脱阴者当补其阳，脱阳者当补其阴。

阴虚阳亢，法当益水，或加细生甘草以泻火，此先天之阴阳也。阴虚而生湿热，法当滋阴，以泻湿热，如六味丸加黄柏、知母，此后天之阴阳也。阴虚而阳无所附，法当峻补其阴，以摄伏阳；阳虚而无所倚，法当峻补其阳，以承领其阴；阴阳两虚，则平补而各居其位。此后天之阴阳而并通乎先天之阴阳也。

相火有二，在少阴者，元阳也；在少阳者，生发之气也。皆须阴以养之。咳嗽大半是火来克金，谓之贼邪，故难愈。在实火固可泻，若虚火惟有壮水之主，然壮水岂常人之能事？又岂可以岁月程功？况乎阴虚于下则痰气壅于上，养阴之药又皆阻气留痰，亦未易仓卒取效也。

刘澹庵曰：此是内伤阴虚，火来克金之嗽。若风寒外入，肺邪未出失解者。久之，火亦克金，传变生痰，又在体认明白。

人有至冬寒时苦，足冷夜半，阳气渐生，其冷愈甚，此亦质壮秋冬，夺于所用病之轻者也。其人上焦必多热，盖两肾阴阳抱负，损一分之阴，即脱出一分之阳。既强力入房，夺其收藏之用，阴精纵未全亏，阳气亦难全藏，是以上焦每多热，下焦每多寒。至秋冬三阴气多，三阳气少之时，足为之冷矣。昼当阳气旺，或能入于阴，子后初生之阳，其气尚微，遂不能入于阴，而足愈冷也。比之夏至，一阴生而天气反热，冬至一阳生，而天气反寒，其理一也。矧脱出之阳，与上焦初生之阳，至此时，两阳搏击于胸中，未免痰气溷滞，此又阳不能入于阴之一义也。《内经》寒厥论云：春夏则阳气多而阴气少，秋冬则阴气盛而阳气衰。此人质壮以秋冬夺于所用，下气上争不能复，精气溢下，邪气因从之而上也。人知秋冬夺于所用，谓秋冬夺于收藏之用，但不知收藏何物。岂知收藏者，指此阳气而言也。阳气至此时收藏肾中，正当思培养之计，为来岁生长化之用，奈何恃其质壮而以入房，遂夺此收藏之用，于是下焦之阳衰矣。衰则求救于上焦之阳，原赖于下焦之阳为之根，今下焦潜藏之阳既衰，而上焦之阳安能复也？阳不能持其阴精，而精气溢下，上下之阳俱虚，时令之寒挟下焦之寒从之而上，故寒厥耳。后人谓夺于所用是精竭于下，上争而求救于母气，肾所去者太过，肺所生者不及，故不能复，如此言则是阴虚之证不当见为寒厥，与阳气衰于下则为寒厥，及阳气衰不能渗营，其经络之旨大相背戾，此盖随文顺释之弊，后学无可适从耳。

肾虚水泛为痰，谓肾中阳虚也，阳虚故水泛溢。若阴虚则是有升无降，咳唾痰涎，二者相去径庭，治法迥别。

火之所以沉伏者，多本于阴虚，无以堵御。经谓：阴脉不足阳往乘之也。故养得一分之阴，即能托出一分之火。如疟疾邪微，正复将欲愈者，口舌反生疮。又伤寒口渴为欲愈是矣。

丹溪阴不足之论，诚为精确，是则当养阴矣。然道家又言纯阳，又是喜阳而恶阴，不知阴阳不可偏胜，亦不可偏负。其相得无间便是真气元气，即生气也。人生动作不衰，皆赖此阳气，然养此阳气，又全赖此阴气，如鱼之有水。所以阴在内，阳之守也。然阴气匮乏一分，则阳气脱出一分，阴气全绝，则孤阳飞越而去矣。善摄生者，外邪不侵，内情不动，茹淡，远则火不作而阴全，阴全则阳气相抱，四肢百骸皆阳气充乎其间，故曰纯阳。苟不知此理，而一味养阳以求生，经曰：有阳无阴，谓之厥阳。厥阳可生乎？

疟之寒热，当知三者之别，一因有形之积留于中焦。夫中焦之气主行营卫者也，为有形所阻，则营卫不能受气而虚，卫虚则恶寒，营虚则发热也。再则因暑邪为阴寒所束，在半表半里之间，一旦发动，薄阴则阴实而阳虐，薄阳则阳实而阴虚，阴虚则发热，阳虚则恶寒也。其三则因气血两靡，气虚则恶寒，血虚则发热也。凡病见寒热，总不越此三者。

张汉颐曰；气血虚恶寒发热说，在疟之寒热条下宜分别。气不足则中焦之气断续而不行，凝结而为胀满痞塞。血不足则不能吸阳气于下，中焦之气亦断续而不行，凝结而为胀满痞塞于此。但当诊其脉症，察阴虚阳虚而补益之，一切破气消导之药不可用也。夫四肢百骸皆受气于胸中，气血虚则周身浮肿，亦如中焦之气断续不行，留结而为胀满痞塞也。于此亦当审其气虚血虚而补益之，浮肿自消，一切消肿利水之药不可用也。

明知逆顺正行无间

呕衄血不止有当下之者，人皆知血出下窍为顺，故其法应施于妄逆之际也。不知血之妄逆皆因于火，治火必用苦寒，苦寒之药能令血凝不流，血不流则气逆呕逆岂能止乎？纵使得药而止，瘀血之患作矣。所以用苦寒下之，俾火降而瘀血不留，斯一举而两得也。

刘澹庵曰：呕衄用苦寒下之，是逐瘀血也。然不若慎用苦寒，无使血瘀不愈于下之乎？

推本阴阳

表之阳附于津液，大汗亡津液，故曰亡阳。里之阳附于肾水，房劳损阴精，故曰脱阳，不然，津液与精皆阴类，何以阳名？

温疟、风温，悉是冬不藏精之人，其寒直中少阴，至春因温而发病。虽有轻重之不同，而致病之由则一也。《内经》、仲景未详其治而但有其论，后人因其论而仿佛其治，总不外甘寒以救肾，辛凉以祛温，独不思肾虚者，肾中之元阴元阳虚也。此

法施之于阴虚之人则可，施之于阳虚之人其可乎？不但知冬不藏精，谓之阴虚，不思阴既虚矣，阳岂能安其位乎？况两肾之中，一点真阳，每曰守邪之神，风寒真中少阴，多由神不能守，此等又可以前法治乎？安得起仲景于九原而细商至当不易之理也？

老人阴虚者，十常八九，阳虚者，百无一二，天地古今之理亦然。试观古人敦厚和平，阴之体也，今人尖锐躁急，阳之体也，世道渐漓，亦指此敦厚和平之阴气渐漓耳。审此则古方治今病断有不可执者，至论进阳退阴，进君子退小人，若《易》之喜复而恶剥，此阳盖指生发之气，阳指肃杀之气，又非谓人身日用消长之阴阳也。

刘澹庵曰：老人阴虚者固有，阴虚者更多，有服参芪附桂，而人不容已，始长年而安保者，则何故耶？是说当论活些，勿执。

寒热，人身中之阴阳耳，治则为阴阳，乖则为寒热。

卫属阳，其气慄悍，故行速；营属阴，其气静翕，故行迟。疟邪之间一日及连二日发者，邪之着于营也，人周天之数，日行过之，月行不及，亦是阴阳迟速之分耳。

生我者非他，五运之气也；死我者非他，亦五运之气也。故有五脏即具五行，及邪之所凑，或真气本虚，或他脏薄乘，则各呈其象而为病，以脉言之，如真脏脉见，即与之决死期。

烧针益阳损阴，今时阴气渐漓，尽从火化，故烧针一法，多不效。非无其传也，时世异也。即岐伯生于今之时，亦当舍烧针而从事汤液矣。治病有失之浅者，见病治病是也。有生之深者，诛伐无过是也。推本阴阳，万举为当。

食养尽之，毋使过之，伤其正也

弦数者，风发也。以饮食消息止之，深得勿药之理。

神气相得，则生化之机不息。故养生家不能无为，而又不可使之有为，此便是天地无心而成化，圣人有心而无为之理。昧者为情欲所牵制而疾病生，所谓吉凶悔吝生乎动也。此岂可以针砭药饵治哉！反观自养可耳。

要知邪气，即吾身中之正气，治则为正气，不治则为邪气，方知养正积自除之说不错。

不澄其源而欲其流之清，不去其薪而欲其汤之不沸，不断厚味而欲其积之可消，此不可得之数也。

病之始起也，可刺而已。其盛可待衰而已。望其文而不知其义，知其义而不详其法，皆不之以言治。请试论之。病之始起不过由于真气失守，邪气乘之。邪气者，内伤外感是矣。其初只是客病，不妨攻之使去，故曰可刺而已。久则正虚而生邪热，既不能补，复不可攻，懾生者，此时当使之慎起居，俾阴精日生，热退则余邪自退，此不治之治，故曰可待衰而已。示病者医者不识待之理与待衰之法，一则躁急以求治，一则杂药以妄投，不死于病而死于医者，踵相接也。

贫痿之人得剧病，多有不服药而自愈者，以其无服药之力，且无治邪之味也。医家以兵法治病，文清野千里，是广服大药。予谓不然。贵在断厚味，使邪无所助而自退，又不战而屈人兵之法也。

丹溪茹淡论最得调摄之法，然阴之所生，本在五味，一味茹淡，亦恐阴气不生。予谓甘肥之味，要在淡煮，使不生痰助火，至于蔬菜，不妨加以盐豉，益其味也。

张汉颐曰：精不足者，补之以味。断厚味在看何病宜，何当忌则是。如肿胀食盐助邪，可类推矣。若一意教人淡食，则恐胃气日惫，精神顿消，而不可回者矣。若肥味淡煮，可谓得情。

微妙在脉不可不察

《内经》曰：血虚脉大。然气虚亦有脉大者。盖血虚气无所附故脉大；气虚则邪火甚，故脉亦大，此种经旨皆有，但未尝明白指示，此道之所以常不明耳。

脉细小之类，为正气不足，洪大之类，为邪气有余。正气不足而见细小之脉，可补而愈也，邪气有余而见洪大之脉，可泻而愈也。唯是正气不足而脉反洪大，邪气有余而脉反细小，一则正虚邪胜一则邪胜正虚，故皆不治。诊者先知此种大意，则不难迎刃而解。问病然后察脉，以病合脉，其脉得，其病亦得。若以脉求病，则二十四脉每部各有寒热虚实证候纷纭，何能一按了然？譬如浮脉，浮而有力为风；浮而无力为虚似矣，然中风脉浮而缓，缓之与无力相去几何？譬之沉脉，沉而有力为实，沉而无力为虚似矣，然中寒脉沉而微细，微细之与无力相去几何？又如弦脉，邪在少阳则脉弦，血虚脉弦，风家脉弦，支饮脉弦，苟不问其人之壮怯，及表里阴阳，有何痛苦，所谓猝持寸口，何病能中？况噤之以声息，蔽之以帷幄，此非睿医，实自贻其咎耳。脉如车盖，如羹上浮，是阳气将绝也。如屋漏，如泻漆，是阴气将绝也。亦自本乎天者亲上，本乎地者亲下之义。

仲景脉浮当以汗解，假令尺中迟者，为营血不足，不可发汗。又曰：脉浮数者，法当汗出而愈，若下之身重心悸者，不可发汗，当自汗出乃解。所以然者，尺中脉微，此里虚须表里实，津液自和，便自汗出愈。凡脉浮取之盛，按之不足，寸关盛，尺不足，其盛皆为假象，盖沉之与尺，犹树之有根也。故仲景于当汗之症，迟回顾

虑，如此予更有说焉。夫浮以候表，寸以候阳，外邪初入，必先在于表与阳分，表盛则里虚，上盛则下虚，此时似难以尺中迟微而误当汗之期，犹必须审其人之形气病气何如也。若其人无外邪，脉见沉候，与尺不足，此真是有阳无阴，枝叶虽茂，根本将拔，勿妄施攻击耳。

曰肾气独沉，曰肾气不衡，总是石而无胃，肾水不能上交于心火之象也。

促为阳，紧为阴，然仲景又曰：伤寒脉促，手足厥逆者，可灸之。又曰：手足厥冷，脉乍紧者，邪在胸中，当须吐之。是又不能拘也。

有者为实，无者为虚。仲景又谓阳脉微者汗出而愈，阴脉微者下之而愈，虽曰极虚之处，便是容邪之地，然既极虚矣，汗下岂可轻哉！此亦人存政举之法，后学不得藉以为口实也。

刘澹庵曰：从症不从脉，正在此处要人下手，仲景非立是空头论而眩后人持两端也。

风湿相合，热湿相合，便牵制其善行炎上之性，脉证最难辨别。

色诊以明泽者生，沉夭者死。亦犹脉之有无胃气也。别则于阳者，知死生之期，言无胃气，弹石解索是也。

病之浅者，邪未入于经，病之深者，亦有兼化之象，脉亦难拘。

阳主煦之，阴主濡之。真气虚是阳不能煦，阴不能濡，脉或微而弱，或弦而紧，此一定之理。

色诊不论何色，俱欲其明泽，然光芒浮露之人，又非寿徵，是亦阳亡于外也。故善摄生者，其气深，其神藏，诸病皆有寒热虚实，断不可执已见以为凭。所可凭者，脉耳，然脉又有阴阳格拒之易惑，真假虚实之难明，与夫从脉从症之不可泥，医道可易言哉！

《内经》三部候法，右寸以候肺及胸中，左寸以候心及膻中，此上附上一定不易之理。而叔和《脉诀》又云：右寸以候肺及大肠左寸候心及小肠。后人谓大小肠为下焦，传导浊秽之府，而诊于膈上，清虚之所，此理不伦，遂指《脉诀》为高阳生托叔和之名也。据兰谓《内经》、《脉诀》两论，俱不可废。在《内经》是言身形躯壳内外，在上者诊之于上，而言叔和则以五行配合经脉相络而言，何也？盖欲察病脉，先须知平脉，夫肺系足太阴，主金，大肠系于手阳明，亦主金，脉之浮涩而短，金之体也，安有浮涩而短之脉，亦诊于右尺乎？心系足少阴主火，小肠系手太

阳亦主火，脉之浮大而散，火之体也，安有浮大而散之脉，亦诊于左尺乎？况肺与大肠，心与小肠，确显声应气求，不可移易之证，又宁可以部位拘耶？叔和叙论仲景《伤寒论》，其可指摘处颇多，至于《脉诀》则不可谤矣。又相火藏于九地之下守，谓禀命，确宜诊之于尺，膻中虽曰咽喉之司，当诊于上，然不过为相火之虚位，亦不必于寸求其诊也。

张永孚曰：《内经》以脏腑上下分部位候诊，叔和则以脏腑相络而候诊，不妨并存其说，不为悖理。

必先岁气，无伐天和

二分二至，病之轻者，可望其愈，病之重者，须防其笃，此阴阳互换，人气随之也。天地能鼓铸群品，人亦能范围天地，同在气交中，谁能逃两仪之侵薄？观圣人在位，天无疾风淫雨，非然耶？知此则养生，即病之理锤可在手矣。

寒肃之气，为生发之本。不然，造物者，岂好为此戕贼哉！知此则知天地不可无秋冬之令，吾人身中不可不保金水二脏。

升已而降，降已而生，两已字殊不妥贴。一边升便一边降，是升中有降，降中有升，升者自升，降者自降，奚俟其已耶！不观之二分二至乎？四时之春夏秋冬而配以木火土金水，治病须求其寒热温凉之宜，毋违时，毋违化，用热远热，用寒远寒，宜矣。至于运气则有常有变，有主气有客气，有阳年有阴年，有南政有北政，有胜气，有复气，虽皆一本于乾支，然刚柔强弱，杂乱纷纭，何能按图而索？如土平运曰：备化不及曰卑监，太过曰敦阜。此可考也。少宫之岁而实与太角之岁同，则难可考也。况乎太阳之人，或遇流衍之纪，太阴之人，而遇赫曦之纪，强者有制，弱者得扶，又未可以流衍赫曦之，故而病寒热也。且古今异气，方隅异宜，安能比而同之？故施之于治，往往不可不知。

刘澹庵曰：古今异气，方隅异宜，主气或同，客气则定，有不同者，此在察其气，以知所感者何？属为多比而同施而治之，自不可也。

世有日用寻常之事，童而习之，白首不知其所以然者，如五行相克，水克火，火克金，固易明矣。至于金克木，岂斧斤，以时入仙之谓乎？木克土，岂草木蕃茂土困之而瘠之谓乎？土克水，岂水来土掩之谓乎？是不易明也。在箕子主质而周子主气，后人茫无所宗，予谓水克火，火克金，是言其质之与性；金克木，木克土，土克水，是但言其性。木之敷荣条达，固其性也，金气肃杀，则克之矣。土居中央，其性缓，木之性劲急，则克之矣。水之性寒，湿土之性温燠则克之矣。速其所欲，谓之泻，泻即克也。推此而言，相生之理，亦莫能外之格物致知之学，由浅入深，由粗入精，此等粗浅之处不明，吻口而谈运气得乎！

化气必以五，故五行不可增之为六，减之为四，亦自然之理。

五运六气各具一体用，各具一太极，亢害承制，归于和平。和平者，阴阳相抱，无偏无倚，之谓千万法门，不过欲全此气耳。医有喜寒凉而恶温热，喜温熟而恶寒凉，均未谙此。

运气之说，若按图索骥，似堕马宗素术中。然不深求其理，安知人在气交中，五运六气太过不及，阴阳胜复内外合邪，皆能为病？中庸之理，无往不宜。试以运言之太过不及，皆能致病。如土太过则水受克而火无制矣。土不及则不能生金，而木横肆矣。故曰：母能令子虚，子能令母实，是虚则补其母，实则泻其子之义也。又子逢窃气，母乃力争，母被鬼伤，子来力救之义也。不然造物既以生物为心，又杀之何也？盖理之不得不然者耳。

有毒，无毒固宜常制矣

统而言之，天为阳，地为阴。分而言之，天有天之阴阳，地有地之阴阳，故治者，要知补益阴阳矣。尤不可不知补益阳中之阴，阴中之阳。补阳中之阴，甘寒而气厚味薄者是也；补阴中之阳，苦温而质重味厚者是也。

咸走肾，肿胀之却咸味，以防贼邪者，因脾胃虚不能运化水谷而生湿热，湿热下流，则膀胱之气化不行，小便不通。今使咸味引土邪入肾，肿满不能愈也。茶内着盐，便能消肾，亦是此义耳。

五味子味厚而酸，故能收至高之气以藏极下之地，譬之车论焉，上者能下，而下者方能上。五味如大力者，将此车轮扳之使下耳。

能知桂枝开腠致津液通气，白术、茯苓之生津，则医学之上乘也。

方者，仿也。务必相时令之虚实与时序之寒温仿而用之。王宇泰云：小续命汤亦麻黄桂枝之变，麻黄不施于冬月即之伤寒，而泛施于温热之证，未有不杀人者，其可执乎？

夫辛能燥，以开窍走津液故也。然又曰：辛以润之，其义何居？不知燥气在里，则津液不行，而元府闭塞，故曰肾恶燥，急食辛以润之。开腠理，致津液，通气也。风药治秘，盖本诸此。

有宜先攻后补，其功在补，有宜先补后攻，其功在攻。易医而治，毁誉生焉。殊不知后医之有功即前医无功者有以成之也。易时而治，皆无功焉。所谓客医之治热病，即旧医之乳药也，岂可以有有毒为是，无毒为非，无毒为是，有毒为非乎？

《内经释要》 终

《医津一筏》跋

《医津一筏》一卷，《四库全书》存目中简称曰《医津筏》，清初江之兰撰。书凡十四篇，以《内经》数语为题，而分条疏论于后，说理精确，措词简明。此本乃江君同邑友辑，刊人吴江沈氏昭代业书一集者。沈氏刊书甚多，惜板烬于火，故印本罕见。今春偶检得此册，阅之似与去年《三三医书》第一集内《医经秘旨》相似，遂对校一过，方知《秘旨》前十篇全袭江书，而第一篇内，厕入盛君东宫一案，推本阴阳篇下，缺食养尽之四篇，而增脱阳、遗精等十二则，笔墨不同，体例亦不合，大约坊间射利之徒，因江君无鼎鼎大名，遂伪托盛、高、顾三名。医之名，而著作人之名，与书名均湮没矣。方拟将校勘表覆校缮正，并江书寄社重刊，因俗事鲜暇，因循未寄。近见医报有高思潜君《医经秘旨》校言，知高君藏有《内经释要》铅字本，乃光绪干寅敏修斋所印，幸书名虽改，江君之名未改，高君亦考出伪托之证，且裘君又将《内经释要》拟重刊入《三三医书》三集中，自恨余之因循贻误，未早将此书寄社，依此原本重印。沈氏原本甚精，必较铅本少误夺，以彼易此，使书名及内容数百年后仍复汉氏原书真面目，亦一快事。想高君闻之，谅亦赞成，因邮致吉生社长，未知能俯如所请否。时

民国十四年七月吴门张炳翔叔鹤氏跋时年六十有七